病毒性角膜内皮炎

2023 共识 · 眼科临床速查

正面 · 诊断与处置

诊断与病原检查〔2023 p14–15〕

临床：依据 1（急性起病；感染史 / 免疫下降诱因可有）＋ 3（基质水肿、水肿区 KP、后弹力层皱褶）。病因：依据 1、3 及 4 或 5。4 为 IVCM，猫头鹰眼对应 CMV，非任意 IVCM 异常即可定病原；5 为 PCR 阳性。**PCR 阴性不能排除**，必要时补充房水特异抗体 /G-W。

重点风险与鉴别〔2023 p15–16〕

线状型内皮丢失最快、易失代偿；关注眼压和内皮变化。鉴别前葡萄膜炎、基质炎、Fuchs/Chandler、移植排斥及急闭。正式危险分层、PCR 和眼压处置阈值：**原文未明确**。

病原与局部抗病毒〔2023 p16–17〕

HSV：阿昔洛韦或更昔洛韦；CMV：首选更昔洛韦，**阿昔洛韦无效**；VZV：全身更昔洛韦 / 泛昔洛韦或更高剂量阿昔洛韦（确切量**原文未明确**），局部更昔洛韦。0.15% 凝胶或 0.1% 更昔洛韦滴眼液 4~6 次 /d；痊愈后 2 次 /d，2~4 周。

激素、眼压、手术〔2023 p17〕

在**有效抗病毒基础上**联合：1% 醋酸泼尼松龙或妥布霉素地塞米松滴眼液 4 次 /d。羊脂 / 尘状 KP 消退后，每周减 1 次，至 1 次 /d 后按炎症调整。关注眼压；升高需降压，正常后减停，**慎用前列腺素类**。严重失代偿评估移植；术前后充分抗病毒，术后全身用药通常 3~6 个月。

---

p 为期刊页码（PDF 页码 =p−12）。剂量为 2023 原文摘录，开药前核对。完整证据与研究区别见提取表。

打印：100% 原尺寸 · 双面长边翻转

病毒性角膜内皮炎

2023 共识 · 眼科临床速查

背面 · 用药与随访

成人全身剂量摘录〔2023 p16〕

阿昔洛韦 200 mg/ 次，5 次 /d，7 d；缓解后 400 mg/ d，4~6 个月（原文称“诱导剂量”）。伐昔洛韦 500 mg/ 次，2 次 /d，7 d。更昔洛韦诱导：口服 1 g/ 次、3 次 /d 或慢速静滴 250 mg/ 次、1 次 /12 h，均 14 d；维持口服 0.5 g/ 次、3 次 /d，2 个月。泛昔洛韦口服 0.25 g/ 次、3 次 /d，7 d。

更昔洛韦监测与停药〔2023 p16〕

用前血常规 / 肝肾。诱导：血常规每 3 d、肝肾每周；维持：血常规每周、肝肾每 2~4 周。**停药：肝肾恶化；血小板 ≤ 25×10⁹/L；粒细胞≤ 0.5×10⁹/L 或降至用前 50%**。3 周无效考虑耐药，改膦甲酸钠（二线、肾毒性，剂量**原文未明确**）。

特殊人群与慎用〔2023 p16〕

儿童：阿昔洛韦 10~15 mg/(kg·d)，分 3~5 次、7 d；更昔洛韦 5 mg/(kg· 次)，诱导 2 次 /d、14 d，维持 1 次 /d、2 个月；儿童途径**原文未明确**。**肾损伤避免阿昔洛韦**；泛昔洛韦按肾功能调整（分档**原文未明确**）；**骨髓移植慎用更昔洛韦**。

随访缺项〔2023 p14、17〕

关注 KP/ 炎症、眼压、内皮细胞变化及药物化验。统一复诊间隔、妊娠 / 哺乳方案、正式推荐等级：**原文未明确**。CMV 易复发者适当延长治疗；避免劳累、感冒，加强锻炼。

---

p 为期刊页码（PDF 页码 =p−12）。剂量为 2023 原文摘录，开药前核对。完整证据与研究区别见提取表。

打印：100% 原尺寸 · 双面长边翻转